Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Vicente Ignacio Silva Espíndola				Sexo	F		M ✓
Fecha Nacimiento	16-10-2014	Edad actual	años	meses	País natal:	Chile		
Domicilio actual:	G. de la Fuente 1587 S. de L. Ards.				Teléfono	989829930		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende / habla / lee / escribe					
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende / habla / lee / escribe					
Escolaridad actual:	5°	Establecimiento	Liceo Mixto, Básica 102					

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Shirlie Massiel Espíndola Rojas	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Erika Olguín Briceño	Nombre:
Rol/cargo: Ed. Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

- Solicitar autorización para aplicar evaluaciones
- Recoger datos para anamnesis

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? No **Sí** **(especificar)**

Pediatría:	Psicología: ✓
Kinesiología:	Psiquiatría: ✓
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: ✓	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: (normal) inducido fórceps cesárea (señalar motivo)		
Tuvo asistencia médica durante el parto? (SI) NO	Peso: 2K 694gr	Talla: 46 cm

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

- Nace por parto normal a la semana 37 por cuadro de pielonefritis de la madre.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	No	Traumatismos	Sí	No	Encefalitis	Sí	No
Obesidad	Sí	No	Intoxicación	Sí	No	Meningitis	Sí	No
Fiebre alta	Sí	No	Enfermedad respiratoria	Sí	No	Otra(s) —		
Convulsiones	Sí	No	Asma	Sí	No			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración: 3 días por apendicitis.					
Se realizaron controles periódicos de salud		Sí	No		Vacunas		Sí	No

Observaciones:

Sin observación

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6m	Se sienta sólo/a: 8m	Camina sin apoyo: 11 meses
Primeras palabras: 1a 6m	Primeras frases: 3a	Se viste solo/a: 5a

Controla esfínter vesical Diurno: 3a Nocturno: 3a	Controla esfínter anal Diurno: 3a Nocturno: 3a

Observaciones:

Sin observaciones

En su actividad motora general se aprecia:
normal activo hiperactivo hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
normal hipertónico hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí	No	Caídas frecuentes	Sí	No	Dominancia lateral	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Sí	No	Prensión	Sí	No	Pinza	Sí	No
Ensarta	Sí	No	Dibuja	Sí	No	Escribe	Sí	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Sí	No	Manipula y Explora objetos	Sí	No
Demanda objetos y compañía	Sí	No	Comprende prohibiciones	Sí	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No

Observaciones:

La madre señala que el menor si comprende prohibiciones, pero no obedece.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones: Sin observaciones

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. **Desarrollo del Lenguaje**

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

oral gestual mixto otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): —

Observaciones:

no hay pérdida, pero si atraso en su adquisición

5.5. **Desarrollo Social**

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
natural desmesurada	natural desmesurada	natural desmesurada

Observaciones:

Sin observaciones

5.6. **Estado Actual de Salud del/la Estudiante**

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique): —		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Si, mantiene controles con psiquiatra al día.

Alimentación: normal "malo/a" para comer "bueno/a" para comer Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): normal bajo peso obesidad

Sueño: normal tranquilo inquieto Horas que duerme: 9 hrs.

insomnio pesadillas terrores nocturnos
sonambulismo despierta de buen humor

Duerme: solo acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

alegre juguetón/bromista risueño(a) triste serio rebelde apático violento(a)
Otro:

Observaciones:

Sueño normal gracias a medicación.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Isabella Silva E.	Hermana	5a	NT2	estudiante
2. Felipe Silva F.	Padre	34a	Univ.	Ing. Ciberseguridad
3. Shirlie Espinoza R.	Madre	28	4°E.M.	Est. Universitaria.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

- abuelo paterno con trastornos de personalidad.
- Tío, tía paterno → epilepsia
- abuelo materno diabetes

Observaciones:

Sin observaciones.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	6m	Asistió a jardín infantil sala cuna	✓ Sí	No
N° de colegios en que ha estudiado	4	Modalidad de enseñanza (Regular) (Especial) Técnica :	Esc. de lenguaje	

Motivo de los cambios:

Cambios de domicilio.

Ha repetido curso/s	Sí	✓ No	Curso(s) —	Motivo: —

Situación actual

Nivel/curso actual	6°		**Dificultad de aprendizaje**	✓ Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	✓ No	**Conducta disruptiva**	✓ Sí	No
Asiste regularmente	✓ Sí	No	Asiste con agrado	✓ Sí	No	Apoyo familiar en tareas	✓ Sí	No	Amigos (as)	✓ Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

satisfactorio X insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

X apoyo castigo indiferencia compasión tensión otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

X apoyo indiferencia otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

X expresiones afectivas alimentos preferidos ver TV juguetes tiempo libre otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

X madre padre hermanos/as Otros familiares Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

X alta (incluye al grupo familiar) mediana (incluye sólo madre/padre) baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

Ambos X Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- El estudiante presenta evidente atraso en la adquisición de lectura y escritura.
- El niño proviene de un barrio en Quilicura con alto nivel de delincuencia y violencia, presenció en el año 2022 cuando el padre recibe impactos balísticos
- En 2025 por quiebre de relación de sus padres es llevado a consulte con psiquiatra quien al evaluarlo lo diagnostica con
- el niño comienza tratamiento medicamentoso con desde oct. 2025 a diciembre 2025.
- La madre señala que el menor nunca presenció episodios de violencia tanto física como psicológica, pero comienza a autolesionarse ya que se culpa por la separación de sus padres.
- El psiquiatra indica a la madre que existe la posibilidad de que desarrolle un cuadro de esquizofrenia, pero que será evaluado en la adolescencia.
- actualmente presenta diagnostico de TDA+H y esta en tratamiento con

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY